

Анафілактичний шок

Сценарій

Ви лікар з медицини невідкладних станів. В складі бригади екстреної медичної допомоги ви прибуваєте на виклик до чоловіка 45 років, якого вжалила бджола 1 годину тому.

Скарги: біль (пекуча біль) почервоніння та свербіж в області де вжалила бджола, першіння горла, відчуття набряку губ та язика, задишка, відчуття поколювання біля рта, страх померти.

Анамнез хвороби: Одну годину тому в області задньої поверхні шиї вжалила бджола, в продовж перших 30 хвилин місце укусу почервоніло біль наростала, з'явився свербіж у місці укусу та прилеглих тканинах. Після чого було викликано бригаду ЕНМ.

Об'єктивно: Почервоніння межуюче із кропив'янкою ділянки шиї губ та шок, помірний набряк губ та язика, слабкість, АТ 80/50 мм.рт.ст. PS 125 уд. за хв. Під час проведення огляду з'явилося свистяче дихання, постраждалий став млявим.

Необхідно: провести диференційну діагностику, встановити діагноз, визначити тактику надання невідкладної допомоги, надати невідкладну допомогу.

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з пацієнтом, встановлення контакту.	<i>Сказати</i> <i>Доброго дня. Я лікар центру екстреної медичної допомоги (Ім'я).</i>
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного дослідження	<i>Сказати</i> <i>Ви даєте свою згоду на проведення обстеження та медичних маніпуляцій (Будемо вважати що згода отримана)</i>
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	<i>Сказати</i> <i>Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2. Збір скарг та анамнезу		
2.1	Анамнез хвороби	<i>Сказати «Що з Вами трапилось»</i> <i>Очікуваний відповідь «Одну годину тому в області задньої поверхні шиї вжалила бджола, в продовж перших 30 хвилин місце укусу почервоніло біль наростала, з'явився свербіж у місці укусу та прилеглих тканинах. Після чого було викликано бригаду ЕНМ»</i>
2.2	Скарги постраждалого	<i>Сказати: «Які у вас скарги?»</i> <i>Очікуваний відповідь: «біль (пекуча біль) почервоніння та свербіж в області де</i>

		вжалила бджола, першіння горла, відчуття набряку губ та язика, задишка, відчуття поколювання біля рта, страх померти.»
2.3	Анамнез життя	<i>Сказати:</i> «Які захворювання ви перенесли?» <i>Очікувана відповідь:</i> «ГРВЗ, дитячі інфекції.»
2.4	Алергійний анамнез	<i>Сказати</i> «Чи були у Вас алергійні прояви раніше і на що?» <i>Очікувана відповідь:</i> «Ні, це зі мною вперше»
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Загальний стан.	<i>Сказати:</i> Середньої тяжкості з загостренням симптомі, виявляється: Почервоніння межуюче із кропив'янкою ділянки шиї губ та шок, помірний набряк губ та язика, слабкість, АТ 80/50 мм.рт.ст. PS 125 уд. за хв
3.2	Прогресування хвороби	<i>Сказати:</i> «Під час проведення огляду з'явилося свистяче дихання, постраждалий став млявим»
4. Діагностика		
4.1	Встановити клінічний діагноз	<i>Сказати :</i> Анафілаксія
5.Визначення тактики ведення та лікування. Алгоритм надання екстреної медичної допомоги		
5.1	Перший крок: Рекомендується перша лінія лікування з епінефрином внутрішньом'язово.	<i>Сказати :</i> «Беру шприц та вводжу розчин адреналіну в дозі 0,3-0,5 мл внутрішньом'язово у передньолатеральну ділянку стегна і голосно назвати час введення дози» <i>Сказати:</i> «Ін'єкцію адреналіну можна повторити через 5–15 хв.; більше третини пацієнтів потребують кількох доз.»

5.2	Другий крок: з урахуванням нестабільності кровообігу необхідно надати положення лежачі на спині з піднятими нижніми кінцівками. Третій крок: Всім пацієнтам з анафілаксією слід вводити високу концентрацію кисню через маску до 6-8 літрів за хвилину. Маска повинна бути відповідного розміру. Її слід правильно та щільно надіти на обличчя пацієнта.	<i>Виконати:</i> «Перекласти подушку під ноги чи перевести ножний кінець ліжка у підвищене положення» <i>Сказати:</i> «Щільно надягаю кисневу маску відповідного розміру на обличчя постраждалого та подаю потік 100% кисню 6–8 л/хв.»
5.3	Четвертий крок: Внутрішньовенні рідини повинні бути введені пацієнтам із серцево-судинною нестабільністю. Рідини, які слід обирати в даному випадку, це електроліти, і вони повинні бути введені у болюсах 20 мл/кг (5-10 мл/кг в перші 5-10 хвилин дорослому.	<i>Сказати:</i> «Забезпечую венозний доступ, розпочинаю інфузію 0,9% розчину натрію хлориду в дозі 10 мл/кг. При необхідності швидкого введення розчину, я стискаю флакон»
5.4	П'ятий крок: Після проведення першочергового і другочергового лікування анафілаксії, використовують глюкокортикостероїди. Шостий крок: Для полегшення шкірних симптомів анафілаксії використовуються блокатори H1- та H2-гістамінових рецепторів Сьомий крок: Пацієнти з анафілаксією потребують постійного моніторингу вітальних функцій та переведення до відділення інтенсивної терапії.	<i>Сказати:</i> «Беру шприц та вводжу внутрішньовенно гідрокортизон 2 мг/кг. <i>Сказати:</i> «Беру шприц та вводжу дифенгідрамін в дозі 1 мг/кг (максимум 50 мг) внутрішньовенно» <i>Сказати:</i> «Постраждалий бригадою екстреної невідкладної допомоги доставляється до профільного закладу для подальшого нагляду та лікування».
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	<i>Сказати :-</i> Спокійний режим, уникнення фізичних навантажень, виконання рекомендацій лікарів в подальшому обстеженні та лікуванні.
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	<i>Сказати-</i> Ви повинні знати про можливі ризики, які можуть виникнути при дії алергенів на Ваш організм, і в подальшому при виникненні таких ситуацій не зволікати а одразу викликати швидку.

